低-1 中-2 高-3 很高-4　　1-2（四）心血管危险分层≥3/靶/CKD3无并糖　并/CKD4、5/有并糖

无疑饿、383 无糖 有糖才合适 1234、2234、3444	无其它 危险因素 排掉高血压	1-2 个其它 危险因素	≥3 个其它危险因素 或靶器官损害或 CKD3 期 无并发症的糖尿病	临床合并症 或 CKD≥4 期 有并发症的糖尿病
130-139 和/或 85-89		低	中/高	高/很高
高血压 1 级 140/90	低	中	高	很高
高血压 2 级 160/100	中	中/高	高	很高
高血压 3 级 180/110	高	很高	很高	很高

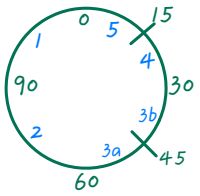
120 ~139 140　80 ~89 90

表 3-5-3　影响高血压病人心血管预后的重要因素

心血管危险因素	靶器官损害	伴随临床疾病
• 高血压（1～3 级） • 年龄＞55 岁（男性）；＞65 岁（女性）男的呜呜求女的留我 • 吸烟或被动吸烟 • 糖耐量受损和/或空腹血糖受损 • 血脂异常 TC≥5.2mmol/L（200mg/dl） 或 LDL-C＞3.4mmol/L（130mg/dl） 或 HDL-C＜1.0mmol/L（40mg/dl） • 早发心血管病家族史（一级亲属发病年龄＜50 岁） • 腹型肥胖（腰围：男性≥90cm，女性≥85cm）或肥胖（BMI≥28kg/m²） • 血同型半胱氨酸升高（≥10μmol/L）	• 左心室肥厚 心脏、血管、肾脏 心电图：Sokolow-Lyon 电压＞3.8mV 或 Cornell 乘积＞244mV·ms 超声心动：LVMI≥115g/m²（男性）；≥95g/m²（女性） • 颈动脉超声：IMT≥0.9mm 或动脉粥样硬化斑块 • 颈股动脉：PWV≥12m/s • ABI＜0.9 踝肱指数减小 • eGFR 30～59ml/（min·1.73m²）CKD3 或血肌酐轻度升高：115～133μmol/L（1.3～1.5mg/dl，男性）；107～124μmol/L（1.2～1.4mg/dl，女性） • 尿微量白蛋白 30～300mg/24h 或白蛋白/肌酐≥30mg/g	• 脑血管病 并发症 脑出血，缺血性脑卒中，短暂性脑缺血发作 • 心脏疾病 心肌梗死，心绞痛，冠状动脉血运重建，慢性心力衰竭，心房颤动 • 肾脏疾病 糖尿病肾脏病，肾功能受损，eGFR＜30ml/（min·1.73m²）CKD≥4 肌酐≥133μmol/L（1.5mg/dl，男性）；≥124μmol/L（1.4mg/dl，女性） 尿蛋白≥300mg/24h • 周围血管病 • 视网膜病变 出血或渗出，视盘水肿 • 糖尿病 空腹血糖 FPG≥7 OGTT 2小时血糖≥11.1 随机血糖≥11.1 HbA1c≥6.5%

注：LVMI，左心室质量指数；IMT，颈动脉内-中膜厚度；ABI，踝肱指数；PWV，脉搏波传导速度。

胰岛素抵抗是T2型糖尿病和高血压的共同发病基础



三、高血压危象

1.原发性或继发性高血压的血压突然＞收缩压 180、或舒张压 120：高于高血压3级

①伴靶器官损害如心、脑、肾→高血压急症。血压高低与急性靶器官损害的程度并非成正比

②不伴靶器官损害→高血压亚急症

急症和亚急症不是看血压，而是看有无靶器官损害

新近 压力

2.高血压急症

①若脑损害突出如脑水肿→高血压脑病；若舒张压≥130+肾损害突出如蛋白尿/血尿→恶性/急进型高血压　最主要死因肾衰竭

②迅速和控制性降压：1 小时内血压降幅≤25%，2-6 小时内血压降至 160/100，24-48 小时逐步降至正常　安全水平　血压波动大会对靶器官产生损害

③高血压急症首选静脉给硝普钠。初期不用呋塞米（除非有心衰或明显体液容量负荷过重）　强效利尿剂使血容量骤然下降，激活RAAS系统，升高血压

④高血压急症的其它药物：①伴急性冠脉综合征可用硝酸酯类　扩血管、扩冠脉　②伴急性脑血管病可用尼卡地平（尼脑子不好）　选择性扩脑血管　③伴妊娠或肾功能不全可用拉贝洛尔（拉宝贝、拉尿）　是α-R、β-R阻断剂　阻断血管α-R，血管舒张增加肾、胎盘血流量

注意：高血压主要是体循环压力（动脉内压力）增高，所以主要选扩动脉降低后负荷的药物

硝普钠可扩小动脉和小静脉、主要扩小动脉（降后负荷）

硝酸酯类可扩小动脉和小静脉、主要扩小静脉（降前负荷）、还可选择性扩冠脉　静止胖屈嗪只能扩小动脉

高血压急症引起急性左心衰，首选硝普钠，但此时初期可以用呋塞米，因为急性左心衰会导致水钠潴留